DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JUAN CRUZ MESA PASIMINIO **Identificación** CC 14805047
Edad: 65 AÑOS **Empresa:** EPS SANITAS REGIMEN CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 07/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**512104**	**COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**	Y41	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**534001**	**HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA**	Y37	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540102**	**LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**	Y40	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**541702**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**	Y38	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**545101**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**	Y40	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES183 CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

512104 **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**
534001 **HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA**
540102 **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**
541702 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**
545101 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**

Dx Preoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Dx Postoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 07/11/26 **Fecha Final** 07/11/26
Hora Inicio 17:00:00 **Hora Final** 18:00:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

BAJO ANESTESIA GENERAL, PREVIA SEPSIA Y ANTISPESIA,
SE COLOCACN CAMPOS ESTERILES, SE REALIZA INCISION TRASNUMBILICAL BAJO TECNICA HASON SE PASA PRIMER PURETO DE 10 MM
SE PASA SEGUNDO PEURTO BAJO VISION DIRECTA FLANCO DERECHO DE 5 MM
SE PASA TERCER PUERTO BAJO VISION DIRECTA SUBXIFOIDEO DE 10 MM
SE EVIDENCIA:
PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS DE GRAN TAMAÑO.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO CORTO
VIA BIALIR PRINCIPALCARACTERISTICAS NORMALES
ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
HERNIA UMBILICAL DE 2X2 CM

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

SE PROCEDE ACON DISECCION Y LEVANTAMEINTO DE ADHRENCIAS A HIGADO Y A ESTOMAGO
SE REALIZA DISECCION ROMA Y CON HIDRODISECCION DE PLASTRON VESIUCLAR
SE EVACUA LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCAL DE 300 ML APROX.
SE IDENTIFICACION LABORIOSA DE TRINGULO DE CALOT, SE TIENE VISION DE SEGURIDAD
SE REALIZA PINZAMEINTO CON CLIPS DE 400 SOBRE ARTERIA CISTICALA CUAL ESTA AUMENTADA DE TAMAÑO PROMEDIO SE CLIPA CON 2 CLIPS Y AL IGUAL A VASO POSTERIOR
SE REALIZA PÍNZAMEINTO CON CLIPS 400 SOBRE CONDUCTO CISTICO SE REALIZA CLIPADO CON 4 CLIPS MUYY CERCA A LA REAIZ DEL CISTICO CON EL CONDUCTO HEPATICO COMUN,
SE REALIZA COLECISTECTOMIA CISTOFUNDICA
LECHO VESIUCLAR CRUENTO Y DE SANGRADO FACIL
SE REALIZA HEMOSTASIA DE LECHO VESIUCALR
SE PROCEDE A LAVADO DE CAVIDAD ABDOMNINAL CON 1500 ML DE LIQUIDOS
Y SE EXTRAEN CUAGULOS
SE RETIRA VESIUCAL
SE TIENE CONTEO DE MATERIAL COMPLETO
SE RETIRAN PUERTOS Y NEUROMPERITONEO
SE REALIZA HERNIORRAFIA UMBILICAL DE 2 CM CON VYCRIL1.
SINTESIS D EPUERTOS CON VYCRIL 1
PIEL Y TCS CONPROLENE 3.0
FIN DE ACTO QUIURURGICO

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS DE GRAN TAMAÑO.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO CORTO
VIA BIALIR PRINCIPALCARACTERISTICAS NORMALES
ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
HERNIA UMBILICAL DE 2X2 CM

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

VESIUCAL BILAIR

Carlos I Forero

CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ
Reg. 760629
CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****